ORL · CO-01

Nodule thyroïdien · EU-TIRADS / ACR TI-RADS

ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017
échographie · indications de cytoponction

EU-TIRADS (ETA 2017, REPRIS PAR L'ETA 2023) · SYSTÈME DE RÉFÉRENCE EN EUROPE

CATÉGORIE	ASPECT ÉCHOGRAPHIQUE	RISQUE DE MALIGNITÉ	CYTOPONCTION
EU-TIRADS 1	Pas de nodule	—	—
EU-TIRADS 2	Bénin : kyste pur, nodule entièrement spongiforme	≈ 0 %	Non (sauf évacuation)
EU-TIRADS 3	Faible risque : ovale, contours réguliers, **iso- ou hyperéchogène**, aucun signe de haut risque	2–4 %	**> 20 mm**
EU-TIRADS 4	Risque intermédiaire : **modérément hypoéchogène**, aucun signe de haut risque	6–17 %	**> 15 mm**
EU-TIRADS 5	Haut risque : **au moins 1** signe parmi forme non ovale (plus haut que large), contours irréguliers, microcalcifications, hypoéchogénicité marquée	26–87 %	**> 10 mm**

Points clés ETA 2023

- EU-TIRADS 5 de 5–10 mm : surveillance active ou cytoponction selon le contexte (localisation, patient)
- Toujours cytoponctionner une adénopathie suspecte, quelle que soit la taille du nodule
- EU-TIRADS 3 < 20 mm : 5–10 mm pas de suivi ; 10–20 mm contrôle à 3–5 ans

Nouvelle cytoponction si

- 1er prélèvement non diagnostique (sauf kyste solitaire)
- Bethesda III
- Discordance : échographie à haut risque et cytologie bénigne
- Croissance significative : ≥ 20 % sur au moins 2 diamètres avec ≥ 2 mm, ou volume > 50 %, ou signes compressifs

ACR TI-RADS (2017) · SCORE PAR POINTS

COMPOSITION	ÉCHOGÉNICITÉ	FORME	CONTOURS	FOYERS ÉCHOGÈNES (ADDITIONNER)
Kystique ou spongiforme **0** Mixte **1** Solide **2**	Anéchogène **0** Hyper- ou isoéchogène **1** Hypoéchogène **2** Très hypoéchogène **3**	Plus large que haut **0** Plus haut que large **3**	Réguliers ou flous **0** Lobulés ou irréguliers **2** Extension extrathyroïdienne **3**	Aucun, queue de comète **0** Macrocalcifications **1** Calcifications périphériques **2** Foyers ponctiformes **3**

NIVEAU	POINTS	CYTOPONCTION	SURVEILLANCE
TR1 bénin	0	Non	Non
TR2 non suspect	2	Non	Non
TR3 peu suspect	3	**≥ 2,5 cm**	≥ 1,5 cm : à 1, 3 et 5 ans
TR4 modérément suspect	4–6	**≥ 1,5 cm**	≥ 1,0 cm : à 1, 2, 3 et 5 ans
TR5 très suspect	≥ 7	**≥ 1,0 cm**	≥ 0,5 cm : tous les ans pendant 5 ans

Croissance significative (ACR) : ≥ 20 % et ≥ 2 mm sur 2 diamètres, ou volume ≥ 50 %. Au maximum 2 cytoponctions (les 2 scores les plus élevés) et suivi de 4 nodules au maximum.

COMPTE RENDU

Pour chaque nodule
localisation (lobe, tiers), 3 diamètres, description complète du lexique

Score
EU-TIRADS (ou ACR TI-RADS si choix local) avec la conduite à tenir

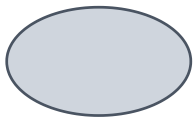
Ganglions
secteurs cervicaux, signes suspects : microcalcifications, kystisation, hyperéchogénicité, vascularisation périphérique

Système
indiquer le système utilisé ; ne pas mélanger les deux

Nodule thyroïdien · EU-TIRADS / ACR TI-RADS (suite)

ATLAS VISUEL

Signes échographiques clés



axe horizontal > vertical

Plus large que haut
0 point



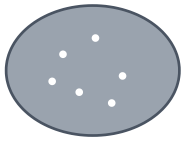
vertical > horizontal

Plus haut que large
+3 · signe EU-TIRADS 5



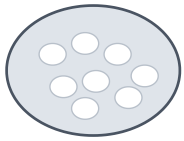
lobulés ou irréguliers

Contours irréguliers
+2 · EU-TIRADS 5



foyers ponctiformes

Microcalcifications
+3 · EU-TIRADS 5



microkystes > 50 %

Spongiforme
bénin · 0 point



artefact en queue de comète

Queue de comète
colloïde · 0 point

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN

ACR TI-RADS
Radiopaedia · points et seuils
radiopaedia.org/articles/acr-thyroid-imaging-rep

EU-TIRADS
Radiopaedia · catégories européennes
radiopaedia.org/articles/european-thyroid-associ

Nodule thyroïdien : démarche
Radiopaedia · approche pratique
radiopaedia.org/articles/thyroid-nodules-an-appr

Carcinome papillaire
Radiopaedia · aspects échographiques
radiopaedia.org/articles/papillary-thyroid-cance

ACR TI-RADS (site officiel)
ACR · lexique et documents
www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-an

Sources : ETA 2023 Guidelines thyroid nodules – www.afthy.fr/wp-content/uploads/2024/11/ETA-2023-GUIDELINES-... · ACR TI-RADS White Paper 2017 – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28372962/ · ACR TI-RADS – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/...